Remaniement de 2015 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Composante annuelle

Dans un effort soutenu visant à assurer que les données produites à partir de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Composante annuelle demeurent pertinentes, qu'elles sont de la plus grande qualité et qu'elles sont recueillies de la façon la plus efficace et efficiente possible, des remaniements en profondeur de l'Enquête sont prévus tous les six à huit ans. En 2012, on a commencé à travailler au deuxième remaniement en profondeur (le premier ayant eu lieu en 2007) pour le cycle de 2015 de l'ESCC. Dans le cadre de ces travaux, des consultations ont été menées auprès des partenaires de partage fédéraux, provinciaux et territoriaux, des responsables des régions sociosanitaires et des chercheurs universitaires. Il en a résulté des changements majeurs apportés à l'ESCC de 2015, y compris des changements apportés au contenu, à la méthodologie et aux stratégies de collecte. La première diffusion des données annuelles de l'ESCC remaniée a eu lieu en mars 2017. Le présent document décrit les changements apportés à l'ESCC de 2015 et les incidences que ces changements pourraient avoir sur l'utilisateur.

Changements apportés au contenu :

Entre 2007 et 2014, le contenu commun (de base et thématique) de l'ESCC est demeuré relativement stable et la priorité a été donnée au maintien de la comparabilité entre les cycles. Dans le cadre du projet de remaniement, l'adoption d'un nouveau plan de contenu en 2015 a offert une occasion exceptionnelle de moderniser et d'améliorer le contenu de l'ESCC. Suivant des consultations approfondies auprès de spécialistes et d'intervenants fédéraux, provinciaux et régionaux, des changements marqués ont été apportés au contenu de la majorité des modules (principalement les modules de base et les modules thématiques). Environ 70 % de tous les modules qui existaient avant le remaniement ont fait l'objet de changements. L'ampleur de ces changements varie; ceux-ci incluent des changements mineurs apportés aux concepts et au vocabulaire, des catégories de réponse révisées et des changements conceptuels majeurs.

En plus des modules eux-mêmes, les règles d'affectation des noms des variables ont également changé depuis 2015. Les règles d'affectation des noms utilisés pour désigner les variables dans l'ESCC de 2015 utilisent un maximum de huit caractères. Veuillez consulter le chapitre 3 du Guide de l'utilisateur de l'ESCC pour obtenir des explications détaillées.

Malgré le fait qu'un plan à long terme soit en place pour le contenu, des changements pourraient tout de même être apportés à ce plan. Des changements pourraient être apportés compte tenu de nouvelles exigences relativement aux données ou pour des raisons opérationnelles. Tous les changements apportés au plan de contenu exigent l'approbation du comité directeur du Programme des statistiques sur la santé de la population canadienne (PSSPC)[1].

---

[1] Le comité directeur du PSSPC est un groupe de travail interministériel réunissant neuf représentants provenant de l'équipe de l'ESCC de Statistique Canada, de Santé Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada. Ces trois organismes sont représentés au sein du comité directeur du PSSPC.

Bases de sondage :

Deux bases de sondage sont utilisées pour l'ESCC depuis 2015. Les échantillons de la population des jeunes âgés de 12 à 17 ans sont tirés de la base de sondage de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFPE), une nouveauté pour l'ESCC. Les échantillons de la population adulte âgée de 18 ans et plus sont tirés de la même base aréolaire que celle qui est utilisée pour l'Enquête sur la population active, qui était aussi utilisée pour une partie de l'échantillon de l'ESCC avant le remaniement. Le fait de disposer de bases de sondage distinctes pour des populations distinctes accroît l'efficacité du plan d'échantillonnage par la réduction des effets de plan. La réduction des effets de plan se traduit par des estimations de qualité équivalente ou accrue avec moins d'interviews.

Base de la Prestation fiscale canadienne pour enfants

La Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFPE) est utilisée pour échantillonner les personnes âgées de 12 à 17 ans. Les jeunes sont sélectionnés au hasard à partir de cette base pour participer à l'enquête avant le début de la collecte. Le principal avantage que présente l'utilisation de la PFPE comme base de sondage est que celle-ci facilite l'échantillonnage direct d'enfants d'âges précis. De plus, presque tous les enfants sont admissibles à recevoir la PFPE. La couverture mensuelle des enfants, c'est-à-dire la proportion d'enfants qui reçoivent des prestations mensuelles, est d'environ 79 %. Cette proportion atteint 93 % de couverture annuelle, car, en plus des enfants qui reçoivent des prestations, la base de sondage inclut aussi les enfants pour lesquels la demande de prestations a été refusée. Par conséquent, seules les familles qui n'ont pas présenté de demande (7 %) ne sont pas incluses dans la base de sondage. Les enfants et les jeunes en famille d'accueil sont inclus dans ce 7 %, parce qu'ils ne sont pas couverts par la PFCE. L'utilisation de la PFCE comme base de sondage permet de mieux cibler un nombre suffisant de jeunes dans l'ESCC, ce qui accroît en conséquence la précision des estimations se rapportant aux jeunes.

Base aréolaire

Pour cibler la population âgée de 18 ans et plus, un échantillon de logements est sélectionné à partir de la base aréolaire utilisée dans l'Enquête sur la population active. Au cours de la collecte, la liste des membres de chacun des ménages vivant dans les logements sélectionnés est établie, puis une personne admissible est choisie au hasard pour participer à l'enquête.

Dans le cadre du dernier remaniement de l'Enquête sur la population active, les renseignements provenant de la base aréolaire ont été élargis grâce aux renseignements issus du Service de la base de sondage pour les enquêtes auprès des ménages. Ce service fournit l'adresse, le numéro de téléphone, ainsi que certaines données socio-économiques de 98 % des ménages au Canada. Lors de l'échantillonnage réalisé pour la première période de collecte de l'enquête remaniée, environ 91 % des ménages avaient une adresse pour laquelle l'envoi par courrier était possible, et environ 83 % avaient au moins un numéro de téléphone associé.

L'ajout des renseignements provenant du Service de la base de sondage pour les enquêtes auprès des ménages a permis d'augmenter le nombre de logements avec numéro de téléphone, ce qui réduit la nécessité des interviews en personne.

Répartition de l'échantillon :

Depuis 2015, une stratégie de répartition de l'échantillon à plusieurs degrés est utilisée afin d'offrir une répartition relativement équitable de l'échantillon aux provinces et aux régions sociosanitaires (RS). L'échantillonnage réalisé pour les territoires a été traité de façon différente et est expliqué ci-dessous. Dans le cas des provinces, le remaniement utilise une approche de répartition par province qui est indépendante du nombre de RS. Si des changements surviennent dans les limites des RS dans une province donnée, les répercussions se feront sentir uniquement à l'échelle de cette province et des RS de cette province. Par ailleurs, une province comptant moins de RS ne sera pas pénalisée par rapport à une autre ayant une taille de population similaire. Le remaniement fournit un échantillon suffisant par province et une taille d'échantillon suffisante par RS pour produire de bonnes estimations en fonction d'une prévalence minimale à chaque niveau. Cette stratégie est conforme au principe d'une répartition par province indépendante du nombre de RS et d'un échantillon suffisant pour produire de bonnes estimations en fonction d'une prévalence minimale dans chaque province et dans chaque RS.

Voici les principaux résultats de cette nouvelle approche :

- Les tailles d'échantillon provincial sont indépendantes du nombre de RS; elles dépendent uniquement de la taille de la population. Cela est plus équitable pour les provinces, étant donné que la taille des RS et leur nombre varient d'une province à l'autre.
- Les changements survenant dans les limites des RS au sein d'une province n'auront pas de répercussions sur la répartition de l'échantillon de la province.
- Chaque province a un échantillon suffisant pour produire de bonnes estimations en fonction d'une prévalence minimale de 2 % (3 % pour l'Île-du-Prince-Édouard) en utilisant deux années de données.
- Chaque RS a un échantillon suffisant pour produire de bonnes estimations en fonction d'une prévalence minimale de 15 % pour la plupart des RS en utilisant deux années de données.
- Les provinces sont responsables des limites de leurs RS et ont la possibilité de les modifier au fil du temps ou de les regrouper pour accroître la précision, au besoin.
- L'utilisation d'une fraction d'échantillonnage maximale d'un ménage sur dix annuellement réduira la qualité dans les petites RS touchées. Un regroupement est recommandé dans ces régions.

Cette stratégie de répartition de l'échantillon remaniée est plus stable et robuste, car elle permet d'obtenir des estimations de qualité semblable pour toutes les RS indépendamment des changements futurs aux limites des RS qui peuvent survenir dans une province donnée.

Pour les trois territoires, la répartition de l'échantillon est réalisée de manière différente. Chaque territoire correspond à une RS unique, et l'échantillon est réparti entre les collectivités qui composent le territoire de manière à assurer que l'échantillon est représentatif de chaque territoire sur une période de deux ans. Cela signifie que le contenu thématique d'une année ne sera pas accessible pour les territoires dans le fichier de deux ans, à moins de sélectionner les mêmes modules comme contenu optionnel pour l'autre année correspondante. Les utilisateurs qui souhaitent obtenir des estimations réellement représentatives à l'échelle nationale devront utiliser le fichier de deux ans, de sorte que les territoires soient inclus.

Collecte :

En 2015, une stratégie dynamique d'obtention des numéros de téléphone a été mise au point afin de maximiser les interviews téléphoniques, en vue de tirer parti de l'accessibilité accrue des numéros de téléphone, y compris les numéros de téléphone cellulaire, couplés aux bases de sondage. Ce changement apporté dans la stratégie de collecte signifie que, pour la portion des personnes âgées de 18 ans et plus de l'échantillon, la priorité est donnée dans la mesure du possible aux interviews téléphoniques par rapport aux interviews sur place. Pour la portion des jeunes âgés de 12 à 17 ans de l'échantillon, toutes les interviews sont menées par téléphone.

Dans le cas de l'échantillon des personnes âgées de 18 ans et plus, les interviews sur place peuvent être utilisées comme suivi des cas de non-réponse, au besoin et lorsque possible au chapitre des coûts et des ressources. Les interviews sur place peuvent également être utilisées afin de communiquer avec les ménages pour lesquels un numéro de téléphone n'a pas pu être repéré. Cette nouvelle approche multimode séquentielle et la liste améliorée de numéros de téléphone connexe entraînent une nécessité moindre et une utilisation réduite des interviews sur place, ce qui se traduit par des économies, étant donné que les interviews téléphoniques sont moins dispendieuses.

Pondération et estimation :

Depuis 2015, compte tenu du changement apporté à la base de sondage utilisée pour sélectionner les jeunes âgés de 12 à 17 ans, des poids ménages sont uniquement produits pour l'échantillon de répondants âgés de 18 ans et plus sélectionnés à partir de la base aréolaire et qui ont été sous-sélectionnés à partir d'un échantillon représentatif de ménages canadiens. Ces ménages comptent également des jeunes âgés de 12 à 17 ans, de sorte qu'il n'y a aucune perte de couverture des ménages canadiens. Des variables au niveau des ménages comme les indicateurs de sécurité alimentaire et le revenu du ménage peuvent être utilisées comme corrélats des indicateurs de la santé pour l'échantillon des répondants âgés de 12 à 17 ans.

Les fichiers des poids bootstrap renferment maintenant 1 000 échantillons répétés. Les échantillons répétés supplémentaires permettront d'accroître la précision des estimations de la variance dans certains cas.

Indicateurs de qualité :

Dans le cadre de l'ESCC, comme pour les années précédentes, il est recommandé d'effectuer les analyses statistiques sur des estimations pondérées et d'utiliser l'indicateur de qualité adéquat. Depuis 2015, le seuil de qualité recommandé pour les coefficients de variation (CV) est passé de 33,3 % à 35,0 %. Ainsi, si une estimation a un CV supérieur à 35,0 %, elle doit être désignée comme étant peu adaptée pour la diffusion selon Statistique Canada. Le changement apporté au seuil des CV a été fait pour appliquer un nouvel outil commun d'estimation de Statistique Canada. Pour obtenir la liste complète des seuils des CV et des indicateurs de qualité, voir le tableau 10.1 du Guide de l'utilisateur de l'ESCC.

Population cible :

Depuis sa création en 2001, l'ESCC cible une population de répondants âgés de 12 ans et plus (entre autres critères). L'un des principaux objectifs du remaniement de 2015 de l'ESCC était d'explorer les possibilités en vue de recueillir des données sur la santé des enfants âgés de moins de 12 ans. À cette fin, une étude de faisabilité a permis d'examiner plusieurs possibilités, y compris la collecte de cette information au moyen de l'ESCC elle-même, la création d'une enquête de suivi à l'ESCC ou l'établissement d'une enquête autonome. Les recommandations de l'étude ont indiqué qu'une enquête autonome sur la santé des enfants constituerait la meilleure option. Dans le cadre de cette nouvelle enquête, appelée l'Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (ECSEJ), un essai pilote a été réalisé en 2016, et le premier cycle de collecte complet est prévu pour 2018-2019. Veuillez consulter le lien suivant pour obtenir plus d'information sur l'ECSEJ.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5233

Incidences sur l'utilisateur – Comparabilité entre les cycles passés et remaniement de 2015 :

Un remaniement en profondeur donne l'occasion d'apporter des changements importants en vue d'améliorer une enquête. Les changements apportés à l'ESCC de 2015 comprennent l'utilisation de bases de sondage de plus grande qualité, l'adoption de stratégies de collecte et de répartition de l'échantillon plus efficaces et un contenu mis à jour et modernisé. Ces changements contribueront à ce que des données de plus grande qualité soient produites dans le cadre de l'Enquête, tout en rendant l'Enquête plus efficace. Cependant, ces changements ont des incidences sur l'utilisation analytique des ensembles de données précédents de l'ESCC.

Compte tenu des changements apportés dans le cadre du remaniement de 2015 de l'ESCC, il n'est pas recommandé de combiner des données des cycles de l'ESCC d'avant et d'après le remaniement (p. ex., combiner les fichiers annuels de 2014 et de 2015), et il faut faire preuve de prudence au moment de comparer les estimations entre ces années. Même les estimations tirées du contenu qui est demeuré inchangé pourraient être touchées par d'autres grands changements apportés à l'Enquête (c'est-à-dire les nouvelles bases de sondage et méthodes de collecte) et ne sont pas nécessairement comparables avec les cycles passés. Il serait difficile de déterminer avec certitude si les changements ou les cohérences entre les estimations produites avant et après le remaniement témoignent d'une caractéristique véritable de la population examinée ou résultent des importants changements méthodologiques et opérationnels apportés à l'Enquête.